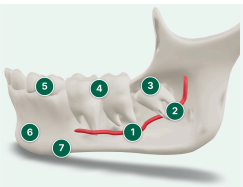
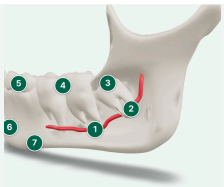
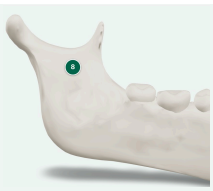
うまっている下の親知らずと、そのそばを通る神経



全体



根と神経（拡大）



舌側

あごの骨と歯　神経・動脈・静脈（下あごの管の中）

モデルの各部分

❶ 下あごの神経（かしそう神経）
- 同じ側の下の歯、歯ぐき、下くちびる、あごの感覚を伝えます。
- かしそう動脈・静脈といっしょに、骨の中の管を通っています。これらも傷つくことがあります。
- 神経が傷つくと、しびれ、ピリピリ感、感じ方の変化、いたみが出ることがあります。一時的なことも、ずっと続くこともあります。
- 年れいが高い人ほど傷つきやすく、完全には治りにくくなります。

❷ 親知らずの根
- 根が下あごの神経に巻き付いています。
- そのため、歯をぬくと神経が傷つくことがあります。

❸ 親知らず（第三大きゅう歯）
- 歯ぐきと骨の下にうまっています。
- 歯ぐきの上に出ていません。

❹ 第一・第二大きゅう歯
- 食べ物をかむ、おくの大きな歯です。
- 親知らずは、この後ろにあります。

❺ 第一・第二小きゅう歯
- 大きゅう歯の前にある歯です。
- これも食べ物をかむのを助けます。

❻ あごの先の神経（おとがい神経）
- 下あごの神経の枝です。骨の小さなあな（おとがいあな）から外に出ます。
- 下くちびるとあごの感覚を伝えます。
- もっとおくで下あごの神経が傷つくと、くちびるやあごの感じ方も変わることがあります。

❼ 下あごの骨
- 神経、動脈、静脈が、この骨の中の管を通っています。

❽ 神経が骨に入る所（小舌）
- 下あごの神経・動脈・静脈は、ここで舌側の小さなあな（かがくこう）から骨に入ります。
- このあなの前のふちにある、小さなとがった骨が「小舌」です。

どんな状態ですか？

親知らずは、いちばんおくにある歯です。「**第三大きゅう歯**」ともよびます。**うまっている下の親知らず**は、歯ぐきと骨の下にあり、歯ぐきの上に出ていません。正しい向きに生えることができません。

神経について

下あごの骨の中には、細い管があり、その中を神経が通っています。ここでは「**下あごの神経**」とよびます。医学での名前は「**かしそう神経**」です。同じ管の中を、2本の血管（**かしそう動脈**と**かしそう静脈**）もいっしょに通っています。[1]

下あごの神経は、顔の感覚を伝える大きな神経「**三さ神経**」の**枝**です。三さ神経の3つの大きな部分のうち、いちばん下の部分（**かがく神経**）から出ています。神経・動脈・静脈は、舌側にある小さなあな（**かがくこう**）から、あごの骨に入ります。[1] このあなの前のふちにある、小さなとがった骨を「**小舌**」といいます。[2]

下あごの神経は、同じ側の下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[3] あごの前の方で、この神経の枝が、骨の小さなあなから外に出ます。この枝を「**おとがい神経**」とよびます。下くちびるとあごの感覚を伝えています。[4]

舌の感覚は、別の神経（**舌神経**）が伝えています。舌神経も、親知らずをぬくときに傷つくことがあります。[5] 舌神経の傷がずっと続くことはまれで、1000人に1〜3人ほどです。[6] このモデルでは、舌神経は表していません。

このモデルでは、**親知らずの根が、神経と動脈に巻き付いています**。

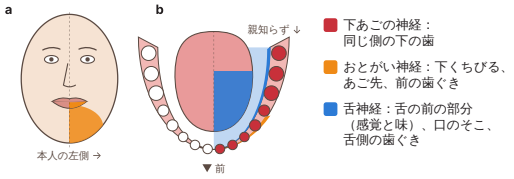
歯をぬくと、なぜ神経が傷つくことがあるのですか？

歯をぬくには、根を骨から取り出す必要があります。根は、神経を囲むように曲がっています。そのため、根を取り出すときに、神経がおされたり、のびたり、切れたりすることがあります。いっしょに通る動脈や静脈が傷ついて、血が出ることもあります。[1]

下あごの神経が傷つくと、その枝のおとがい神経もうまく働かなくなることがあります。[4]

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下くちびる、あご、歯、歯ぐきが、しびれたり、ピリピリしたり、いつもとちがう感じがしたり、いたんだりします。[3,5]



親知らずと同じ側で、それぞれの神経が感覚を伝える所です。神経が傷つくと、この部分の感じ方が変わることがあります。**a：**前から見た顔。**b：**前から見た、下の歯と舌。[7,4,8] この研究のためにかいた図です。

一時的な場合：感覚はもどります。多くは、数週間から数か月かかります。**ずっと続く場合：**感覚が完全にはもどりません。[3]

年れいが高い人ほど、神経が傷つきやすく、感覚も完全にはもどりにくくなります。[3,9]

どのくらい起こりますか？

根が神経に近い親知らずについて、16の研究をまとめた報告があります。結果は次のとおりです。[10]

100人中 約7人
歯を全部ぬいた後に、神経が傷ついた

100人中 約1人
神経の傷が治らなかった

参考にした論文

1. Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e2. doi.org/10.5037/jomr.2010.1102
2. Hsu KJ, Lee HN, Chen CM. J Pers Med. 2022;12(6):1015. doi.org/10.3390/jpm12061015
3. Sarikov R, Juodzbalys G. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401
4. Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e3. doi.org/10.5037/jomr.2010.1103
5. Renton T, Yilmaz Z. J Orofac Pain. 2011;25(4):333-344. PMID 22247929. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22247929
6. Lee J, Feng B, Park JS, et al. PLoS One. 2023;18(2):e0282185. doi.org/10.1371/journal.pone.0282185
7. Khoury J, Townsend G. Anesthesiol Res Pract. 2011;2011:307423. doi.org/10.1155/2011/307423
8. Ngeow WC, Tay HW, Sarna K, et al. Diagnostics (Basel). 2025;15(13):1609. doi.org/10.3390/diagnostics15131609
9. Queral-Godoy E, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(3):259-264. doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.06.001
10. Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459

この資料は、名古屋大学の研究のためのものです。第1.0版（2026年10月16日）。